Actualité

Harald Matthes

Corona et salutogenèse

Quelle contribution peut produire la médecine anthroposophique dans la protection sanitaire vis-à-vis du covid-19 ?

Au début de l'année [2020, *ndt*] l'OMS devint attentive à un nouveau type de virus au moment où 41 personnes développèrent une inflammation pulmonaire au marché d'alimentation en fruits de mer de Huanan dans la ville chinoise de Wuhan. L'agent pathogène s'avéra être un coronavirus (SARS-CoV-2) et passe pour provoquer une nouvelle zoonose, c'est-à-dire un virus qui passe du monde animal à l'être humain. De telles zoonoses peuvent représenter un danger potentiel plus élevé, étant donné que le système immunitaire de l'être humain ne pouvait pas développer une immunité contre le virus jusqu'à présent. D'autres infections passent aussi pour être des zoonoses, telles que Ebola ; HIV, de la grippe aviaire (SARS-1) ; MERS ou Zika-virus. Le taux de létalité (= taux de mort par infection) se s'étend pour Ebola de 50 à 90 % ; avec l'HIV, sans thérapie, il est de 100 % dans les premières années, dans les dernières zoonoses comme la fièvre Nipah, 40 à 70 % ; et le pour le coronavirus MERS, entre 20 à 40 %. Ainsi au début de l'apparition du covid-19, la question de la dangerosité se posait-elle directement pour les êtres humains.

Après quelques hésitations, des mesures drastiques furent prises en Chine — la mise en quarantaine de vastes cohortes (la totalité de la ville de Wuhan, soit quelques 11 millions d'habitants), la contrainte d'isolement, la cessation de la liberté de voyager et de circulation, l'obligation de porter un masque en public, etc. Ceci fut porté et recommandé par l'OMS. Mais encore après plus de 80 000 infections au covid-19 en Chine, aucuns faits épidémiologiques et cliniques, auxquels on eût pu se fier n'avaient encore été acquis, étant donné que la transparence et la qualité des données y restaient limitées.[1]

Ce n'est qu'après une large diffusion dans d'autres états asiatiques, tels que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong, que des donnés fiables furent enfin accumulées et évaluées. Une double nature se révéla alors : d'une part, de nombreuses infections au covid-19 évoluaient de manière asymptomatique et douce, 80 à 90,1 % des infectés ne manifestaient aucuns ou peu de symptômes, tels un raclement de gorge, une toux sèche, ou de légers symptômes de grippe.[2] D'autre part, entre 5 à 8 % des malades montraient des symptômes plus graves au point que 1 à 2,5 % de ceux-ci nécessitaient un traitement de médecine intensive. Une patientèle plus à risques put être précocement décrite : personnes âgées multi-morbides (plus de 70 ans), personnes atteintes d'affections respiratoires, hypertendues, diabétiques, en sur-poids et immuno-déprimées (par exemple, sous l'effet de médicaments). Ce groupe représentant au maximum, 2,5 % des personnes infectées, montraient une évolution grave, voire dramatique, avec une détresse respiratoire, et une grave défaillance pulmonaire (*sARD =severe Acute Respiratoty Distress Syndrome [SARD = Syndrome de détresse respiratoire sévère aiguë]*) ainsi que des défaillances organiques multiples (reins, cœur-circulation, etc). Dans ce groupe, malgré les soins de médecine intensive, on observait une mortalité élevée entre 30 à 70 %. Chez les personnes multi-morbides dépassant l'âge de 85 ans, en dépit de la procédure de respiration artificielle (*ECMO : Extracorporale Membranoxigenierung [ECMO : Oxygé-*

1 Adam J. Kuchaski *et al. : Early dynamics of transmission and control of COVID-19 : a mathematical modelling study [Dynamique précoce de transmission et de contrôle de la COVID-19 : une étude de modélisation mathématique]* dans ***The Lancet-Infectious Diseases*** 2020.

2 Kenji Karako *et al. : Analysis of COVID-19 infection spread in Japan based on stochastic transition model [Analyse de la propagation de l'infection au COVID-19 au Japon basée sur un modèle de transition stochastique]* dans ***Bio-Science Trends*** 2020 ; Hiroschi Nishiura *et al : The Rate of Underascertainment of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection : Estimation Using Japanes Passengers Data on Evacuation Flights [Taux de sous-estimation de l'infection par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) : estimation à l'aide des données des passagers japonais sur les vols d'évacuation]* dans ***Journal of Clinical Medicine***, vol. **9/2** (2020).

nation membranaire extracorporelle]) la survie s'avérait inférieure à 10 %. Le taux de mortalité global pour toutes les personnes infectées était d'environ 0,3 à 0,7 % et ne dépassait pas la barre des 1 à 3 % que dans les régions aux traitements médicalement insuffisants. Le problème principal pour ces données de mortalité fut l'insuffisante donnée du taux global des infectés, étant donné qu'environ 80 % d'entre eux connaissaient une évolution douce de la maladie et n'étaient donc pas testés. Ainsi le SARS-CoV-2 présentait-il un risque nettement plus faible que les précédentes zoonoses et son taux de mortalité globale était 2 à 3 fois plus faible que pour l'authentique virus de la grippe (A ou B).

Le même virus provoquait donc des évolutions cliniques diverses, de sorte que — outre une caractérisation du virus lui-même — son interaction devait être étudiée avec l'être humain. Ainsi était-il déjà précocement clair que les évolutions graves étaient conditionnées par les propriétés de l'hôte, c'est-à-dire par une réaction hyper-inflammatoire (sur-réaction fébrile) au virus.[3]

Dualisme du système de la médecine

Deux manières de voir essentielles déterminent notre système médical actuel :

- **1.** L'amorce médicale *pathogénétique* s'interroge sur le « pourquoi » d'une maladie. Des infections par virus ou bactéries sont pathogènes en cela qu'elles nous rendent malades. Des facteurs de risques déterminés (âge, co-morbidités…) conditionnent l'évolution et la gravité d'une maladie. Les stratégies de traitement visent à tenter d'anéantir le pathogène ou de l'écarter. Il en résulte en Allemagne un système de santé « protecteur ».
- **2.** L'amorce médicale salutogénétique s'interroge par contre : « Comment resté-je en bonne santé ? » Le dessein se porte sur les facteurs de protection et les ressources de l'individu. La réponse du système de santé est constituée par la capacité propre au soi, l'aide de soi et l'évolution résiliente.

La vision dominante de la médecine occidentale conventionnelle c'est jusqu'à présent l'orientation pathogénétique. Dans la médecine complémentaire, c'est traditionnellement l'amorce salutogénétique qui est mise au premier plan. La médecine anthroposophique, en tant que système de médecine intégrative moderne, relie les deux manières de voir pleinement valables, étant donné que les deux principes ne s'excluent nullement, mais se complètent au contraire.[4] En prenant compte des divers systèmes médicaux de valeur, diverses évaluations peuvent en résulter.

Les stars de la pandémie coronaïque sont les virologues dans le système médical orienté sur la pathogénicité. Ces spécialistes passent pour des experts qui accompagnent constamment les politiques sur les conférences de presse fédérales. Ils mirent en branle une spirale de l'angoisse jamais connue auparavant, enflammer par les médias à leurs basques et ils sont saisis par le politique du fait que l'époque favorise les hommes forts qui font irruption dans les médias. La terminologie guerrière devint la langue d'état et les contraintes et restrictions sont bien entendu présentées comme sans alternatives, et cela va si loin qu'aucune contradiction n'est plus guère tolérée.

Cependant, les réglementations édictées reposent sur un terrain fragile, car l'article **28** de la loi sur la protection contre les infections (*ifSG*) restreint les droits fondamentaux, mais seulement si elles sont édictées par « l'autorité responsable », c'est-à-dire les autorités sanitaires et non par les .

---

3 Voir Pio Conti *et al. : Induction of pro-inflammatory cytokines (IL-1 and IL-6) and lung inflammation by cronaviruse-19 (COVI-19 or SARS-CoV-2) : anti-inflammatory strategies* [*Induction de cytokines pro-inflammatoires (IL-1 et IL-6) et inflammation pulmonaire par le coronavirus-19 (COVID-19 ou SARS-CoV-2) : stratégies anti-inflammatoires*] dans : ***Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents*** Vol. **34/2** (2020) ; Yajing Fu *et al. : Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses : From Mecanisms to potential Therapeutic Tools [Comprendre les réponses inflammatoires induites par le SARS-CoV-2 : des mécanismes aux outils thérapeutiques potentiels],* dans : ***Virologica Sinica***, 2020 ; Puja Mehta *et al. : Covid-19 : Consider cytokine storm syndromes and immunosuppression [Envisager les syndromes de tempête de cytokines et l'immunosuppression],* dans : ***The Lancet*** du 16 mars 2020.

4 Michela Glöckler, Matthias Grike & Harald Matthes : *Anthroposophische Medizin und ihr integratives Paradigma [Médecine anthroposophique et son paradigme intégratif]* dans : Rahel Uhlenhoff (éditeur) : *Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart [L'anthroposophie dans l'histoire et le présent]*, Berlin 2011, pp.515-612.

gouvernements des États. Si les structures fédérales dans les domaines de l'éducation, de la science et de la santé sont par ailleurs considérées comme essentielles, le gouvernement fédéral devrait désormais exercer la souveraineté sur les questions d'importance nationale grâce aux modifications de l'**I*fSG*** [***Inf****ection****S****chutz****G****esetz* :**L**oi de **P**rotection contre l'**Inf**ection, *ndt*]. Par mesure de précaution, la personne qui définit ces endémies n'est pas déterminée. C'est donc l'heure de l'exécutif – sans négociation par le législatif, ni débats démocratiques. C'est tout juste si un juriste constitutionnel ose encore la contradiction en public. L'opposition se replie [apeurée ?, *ndt*] ceux qui pensent autrement sont diffamés et la dénonciation ou la délation deviennent un « sport national » de ceux qui sont soi-disant bons. L'utilité des différentes mesures n'a apparemment plus besoin d'être expliquée, car celle-ci est déjà réclamée de tous les côtés, dans les médias. Au contraire, le rétrécissement de l'horizon décisionnel, motivé par la peur, est largement approuvé et la réputation des partis au pouvoir est actuellement considérée comme renforcée. L'objectif qui rend tout cela possible, c'est uniquement d'éliminer la menace de la pandémie de Covid-19.

But d'une stratégie de maîtrise du Covid-19

Cela étant, quelle amorce de salutogenèse résulte-t-il pour la pandémie du covid-19 ? Aucune nouvelle zoonose n'a pu encore jamais être refoulée dans le règne animal. Lors d'une propagation plus vaste, telle que la pandémie la représente, le virus doit être endigué par une immunité de groupe [en allemand c'est *Herdenimmunität,* soit l'immunité du « troupeau », *ndt*]. Seules les infections locales peuvent être contenues plus longtemps grâce au confinement (mise en quarantaine) et à la mise en isolement. En cas de pandémie, un renforcement immunologique par infection ou vaccination est nécessaire. Étant donné que cette dernière ne fut pas à disposition avant 2021 et qu'ensuite la question de son efficacité resta encore ouverte, une stratégie doit être découverte qui désigne des objectifs et des voies claires. Cela requiert la collaboration des divers domaines issus de la médecine, par exemple, les épidémiologues, infectiologues, la médecine intensive, les pédiatres, les hygiénistes, etc. Une évaluation du covid-19 nécessite donc une vision d'ensemble et un débat scientifique, par exemple au moyen d'une commission *ad-hoc*. Au lieu d'examiner l'agent pathogène du SRAS-CoV-2 en tant que tel, une évaluation des risques, et donc une stratification des risques, et des scénarios différents doivent être réalisés de manière orientée vers les solutions.[5] Ces problèmes complexes requièrent une manière de procéder différenciée lors de laquelle, outre l'évaluation médicale proprement dite, les options d'action doivent aussi être évaluées aux plans psychosocial, sociétal et économique. Le savoir ne doit pas rester au pouvoir d'un seul, mais doit devenir une responsabilité sociétale. Les vraies forces de la démocratie sont l'affrontement verbal, le discours et les débats. Si jamais ceux-ci régressent alors les sirènes d'alertes doivent toutes retentir en Allemagne! Une force fausse s'est dévoilée en compensation d'une faiblesse.

L'objectif nécessaire le plus élevé c'est donc d'atteindre l'immunité de groupe, afin que l'infection au covid-19 perde aussi sa létalité pour les groupes à risques. L'objectif salutogénétique de l'immunité individuelle, c'est-à-dire l'expérience corporelle d'apprentissage de l'individu vis-à-vis du covid-19, apporte la seule et unique solution à long terme. À moyenne échéance, le but doit être de minimiser les dommages psychosociaux et économiques pour la société au moyen d'une limitation du contact et le but à court terme représente l'évitement d'une violation de la capacité de soins de la protection de la santé.

Au lieu de laisser venir les systèmes de santé locaux au bord de l'effondrement, une action supra-nationale, disposant d'une coordination centrale et d'une « médecine touristique européenne », laquelle à différents moments partage, dans les diverses régions, les lits de respiration artificielle requis en médecine intensive, par exemple. Pendant qu'au début d'avril, par exemple, en Italie, France et Espagne, la capacité en lits de médecine intensive était déjà épuisée, il restait encore dans le même temps, en Allemagne, 70 % de l'ensemble des lits disponibles qui étaient vides.

5 Voir les analyses des modèles épidémiologiques dans la video : *Simulating an epidemic. 2020* — www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs&t=822

Au lieu des restrictions générales de contact et d'un *shutdown* [fermeture (définitive), *en anglais dans le texte, ndt*] pour la société et l'économie, en procédant avec une adaptation et une différenciation des risques, cela serait bien moins destructeur. Seul un maximum de 20 % de la population allemande peut être considéré comme un groupe à risque d'évolution grave de l'infection Covid-19. Une protection conséquente de ce groupe en éloignant autant que possible les 80 % restants et des tests conséquents des personnes au contact, pourraient minimiser la transmission de l'infection Covid-19 pour celles-ci. La grande majorité de la population formerait peu à peu une immunité de groupe avec des évolutions d'infection relativement douces et les nuisances sociétales et économiques qui en seraient nettement moindres. Au lieu de cela, des restrictions générales de contact ont été imposées et les capacités de test limitées n'ont été utilisées que pour les personnes présentant des symptômes (environ 15 % des personnes infectées), même si l'on savait que les personnes plus jeunes, en particulier, contractent l'infection avec peu de symptômes et sont donc porteuses de maladies pour le groupe à risque. Avec des moyens expérimentaux et des matériels limités, les appliquer à l'ensemble de la population et se retrouver ainsi dans des situations de pénurie constante (de masques, de vêtements de protection, de lits de ventilation, etc.) c'est moins efficace que de les appliquer spécifiquement et systématiquement aux 20 % de la population du groupe à risque dès le départ.

L'exemple de l'Havelhöhe

L'hôpital communautaire Havelhöhe à Berlin fut une des premières cliniques qui mit en place une clinique ambulatoire coronaïque d'accueil, comme on l'appelle. Grâce à des conseils via une *hotline* téléphonique en amont, des tests, des diagnostics et des recommandations comportementales, ce centre est devenu le plus grand centre de conseil de Berlin pour les infections au Covid-19, avec jusqu'à 600 contacts par jour [C'est exactement ainsi qu'a procédé l'IHU de Marseille en collaboration avec l'hôpital du lieu en France, *ndt*]. Alors que de nombreux médecins en exercice à Berlin ont d'abord montré leur peur de la pandémie et ont arrêté leurs opérations en raison d'infections au Covid-19 et par leurs explications, nos jeunes collaborateurs, en particulier, ont compris et abordé la nécessité de visiter et d'apaiser de larges groupes de population. Les médecins pédiatres refusèrent les enfants ayant une forte fièvre et les adressèrent à la clinique ambulatoire de l'*Havelhöhe.* À partir de là, un nombre croissant de personnes testées positives pour le SRAS-CoV-2 et gravement malades ont été accueillies, de sorte qu'il a fallu exploiter un service d'infection de 35 lits. Dans le même temps, la capacité d'accueil respiratoire fut triplée pour atteindre 49 lits et beaucoup de personnel des stations normales de l'hôpital fut formé à la médecine intensive. De l'environnement de la clinique plus de 40 soignants et 30 médecins furent recrutés en supplément. Les patients connurent la plus grande détresse sur la station d'infection par l'isolement social ! Avec l'essoufflement et la fièvre, l'oppression envahit de plus en plus l'âme. Le plus important pour eux devint la rencontre et la proximité humaines. Ils souhaitaient des consultations psychologiques et adoraient les applications des soins par les infirmières telles que les enveloppements, frictions et applications.

En fin de compte, la pandémie de Covid-19 se révèle comme une crise de la culture de la rencontre. Les virologues orientent la société et la politique vers une vision tunnellaire fondée sur la peur. Le discours interdisciplinaire et interprofessionnel dans la science demeure absent et la politique perd aussi sa capacité de discussion et elle démontre ses prétendues forces par des restrictions et des ordonnances avec des menaces d'amendes. La médecine anthroposophique en tant que système de médecine intégrative ne méconnaît en aucun cas la pathogénicité du SARS-CoV-2, mais elle permet de poser, authentiquement à côté, un aspect de salutogenèse aussi nécessaire. En surmontant la peur une vaste offre médicale pouvait donc être proposée pour traiter l'infection du covid-19 ce qui déclencha une grande reconnaissance dans la population et les médias.

***Die Drei* 5**/2020.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Le professeur-Docteur en médecine ***Harald Matthes*** *est médecin-chef de l'hôpital communautaire anthroposophique de l'****Havelhöhe*** *à Berlin.*